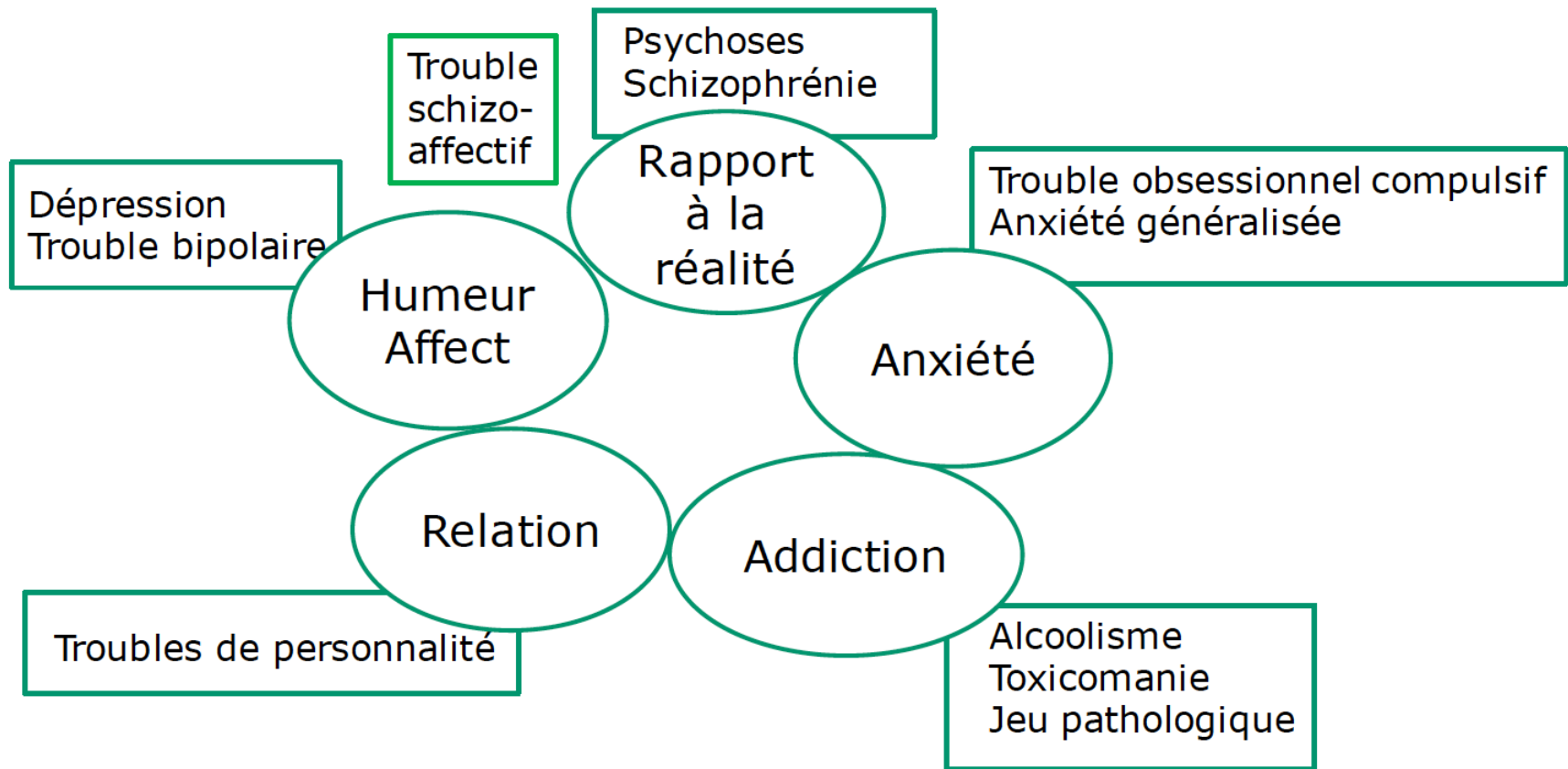


Répétitoire MMed3 2019

Prof P Conus

Principaux syndromes chez l'adulte, en fonction des domaines perturbés



Schizophrénie

Le frère jumeau (monozygote ou « vrai jumeau ») d'un jeune patient qui souffre d'une schizophrénie vient vous voir pour vous demander quel est le risque qu'il développe lui aussi la maladie. Quelle est la réponse la plus proche de la réalité ?

- A. 1%
- B. 15%
- ☒ C. 50%
- D. 85%
- E. 100%

Schizophrénie

Laquelle des affirmations suivantes au sujet de la schizophrénie est **fausse** ?

- A. Le stress joue un rôle dans la survenue d'épisodes aigus
- B. Le délai avant la mise en route d'un traitement est souvent très long
- ☒ C. Son traitement est exclusivement médicamenteux
- D. Elle se déclare dans la majorité des cas entre 15 et 25 ans
- E. L'environnement peut jouer un rôle dans son développement

Schizophrénie

A propos de schizophrénie, laquelle des affirmations suivantes est **correcte**?

- A. Cinq ans après un premier épisode, moins de 15 % des patients présentent une rémission des symptômes positifs
- B. En moyenne, les femmes font leur première décompensation à un plus jeune âge que les hommes
- C. Il vaut mieux ne jamais évoquer le diagnostic de schizophrénie avec un patient, car il est trop stigmatisant
- D. La prévalence de la schizophrénie dans la population générale est de l'ordre de 1 pour mille
- E. Environ 80 % des patients schizophrènes souffrent de troubles d'au moins une fonction cognitive (attention, mémoire, fonctions exécutives, etc.)

P. Bovet

Symptômes dits «positifs»

- Délire
- Hallucinations
- Troubles de la pensée formelle
- Automatisme mental (troubles de l'intimité de la pensée)
- Bizarreries majeures du comportement
- Affects inappropriés

Symptômes dits «négatifs»

- Pauvreté du langage (alogie)
- Abrasement des affects
- Inhibition de la volonté (avolition)
- Inhibition de l'agir (apragmatisme)
- Perte du sentiment de plaisir (anhédonie)
- Sociabilité diminuée

Troubles des fonctions cognitives

(essentiellement préfrontales)

- Mémoire (yc mémoire de travail)
- Capacité d'abstraction et de catégorisation
- Capacité de planification
- Focalisation de l'attention
- Attention soutenue

Symptômes de base

- Bizarreries perceptives: surtout visuelles, auditives, cénesthésiques et proprioceptives
- Troubles de l'expérience motrice (perte des automatismes)
- Troubles du sentiment de «présence» (dépersonnalisation, déréalisation, sentiment de «déjà vécu»)

Schizophrénie

Le père d'une jeune fille de 18 ans rapporte au médecin de famille son inquiétude à l'égard de sa fille, qui présente depuis 6 mois un changement de comportement alors qu'elle avait mené sa scolarité et le début de son apprentissage sans problème. Après être devenue plus renfermée, elle s'est progressivement coupée de son cercle d'amies. Souvent enfermée dans sa chambre, elle refuse de partager les repas avec le reste de la famille, se montre irritable et parle seule. Quand le père tente de lui parler de son état, elle se fâche, lui dit de ne pas se mêler de ses affaires à elle et qu'il ferait mieux de s'occuper des voisins qui la surveillent depuis quelques semaines. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Episode dépressif
- ☒ B. Psychose débutante
- C. Phobie sociale
- D. Episode maniaque
- E. Anorexie

Schizophrénie

Comme médecin de premier recours, vous prenez l'anamnèse familiale d'une jeune femme de 20 ans qui vous consulte pour des sensations de tiraillement dans la tête et de décharges électriques qui sautent d'une partie du corps à l'autre. Elle évoque son grand-père paternel, âgé de 75 ans, et dit qu'il a fait dans sa vie plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, dès l'âge de 25 ans, pour « une dépression », mais, il n'a jamais été hospitalisé depuis qu'elle est née. Il prend depuis de nombreuses années, tous les jours, des médicaments pour ces difficultés; il est assez renfermé sur lui-même, parle parfois tout seul, a les mains qui tremblent souvent et une démarche un peu rigide. Il aime encore beaucoup s'occuper de son jardin. Vous suspectez **chez ce grand-père** une histoire de:

- A. trouble mélancolique délirant
- B. démence alcoolique
- ☒ C. schizophrénie résiduelle
- D. maladie de Parkinson
- E. démence vasculaire

Schizophrénie

Parmi les affirmations suivantes, laquelle est **la plus correcte** concernant les antipsychotiques atypiques comparés aux neuroleptiques classiques ?

- A. Ils induisent moins de prise pondérale
- B. Ils sont plus efficaces sur les symptômes psychotiques positifs
- C. Ils sont plus efficaces sur les symptômes négatifs
- ☒ D. Ils ont moins d'effets secondaires extrapyramidaux
- E. Ils coûtent moins cher

Aspects légaux

Un patient est trouvé dans la rue en état d'agitation important. Il tient des propos délirants et se montre menaçant à l'égard des patients. Qui pourrait ordonner son admission en hôpital psychiatrique?

- A. Le curateur du patient
- B. Les proches de la personne
- C. Le représentant thérapeutique
- ☒ D. Son médecin généraliste
- E. Son orthopédiste

PLAFA

Médecins autorisés à ordonner une mesure de PLAFA médical:

- Médecin de premier recours
 - Généraliste interniste
 - Pédiatre
 - Médecin des urgences
- Psychiatre
- Médecin délégué (par la Justice de Paix)

Personnes autorisées à prononcer une mesure de PLAFA judiciaire (ou civile):

- Juge de paix

Aspects légaux

Qui, dans le domaine des soins, peut représenter légalement une personne incapable de discernement?

- A. Le médecin traitant
- B. Le voisin de la personne
- ☒ C. Le représentant thérapeutique
- D. Le conseiller accompagnant
- E. Les soignants

Aspects légaux

Parmi les affirmations ci-dessous concernant les droits des patients en Suisse, laquelle est **fausse** ?

- A. Toute personne a le droit de rédiger des directives anticipées pour spécifier le type de soins qu'elle désire
- B. Les soignants ont le devoir de signaler les situations de maltraitance sur des mineurs dans le canton de Vaud
- C. Les mineurs ne peuvent pas avoir accès à leur dossier médical**
- D. Les mesures de contrainte peuvent exceptionnellement être autorisées, leur nécessité devant alors être réévaluée
- E. Le secret médical fait l'objet d'un article du Code pénal

Aspects légaux

Laquelle des mesures suivantes peut être une mesure de contrainte au sens de la Loi:

- A. une mesure juridique qui oblige une autorité à prendre en charge un patient
- B. une mesure qui oblige un médecin à soigner un patient
- C. une mesure punitive
- ☒ D. une mise en chambre de soins intensifs fermée
- E. une prescription régulière de médicament

Suicide

A propos du risque suicidaire, **laquelle de ces propositions est juste ?**

- A. Il faut hospitaliser tous les patients qui évoquent des idées suicidaires
- ☒ B. L'existence de tentatives de suicide antérieures qui n'ont pas abouti augmente le risque d'un suicide réussi
- C. Lorsqu'un patient décrit en détail le scénario qu'il a imaginé pour se suicider, on peut considérer que le risque est faible car le patient est capable d'en parler
- D. La grande majorité des patients (>70%) ayant réussi leur suicide présentaient peu auparavant les symptômes caractéristiques du Trouble dépressif majeur
- E. Il vaut mieux évoquer le risque suicidaire avec les proches d'un patient plutôt qu'avec celui-ci, car parler de ce sujet augmente le risque de passage à l'acte

Evaluation du potentiel suicidaire

- **Risque:** facteurs prédisposant sur le plan épidémiologique, augmentant le risque de mourir par suicide
- **Urgence:** imminence de la conduite suicidaire – degré d'élaboration du scénario suicidaire (où, quand, comment, avec quoi)
- **Dangerosité:** létalité et accessibilité du moyen

Risque

- Tentatives précédentes
- Troubles psychiatriques (90%)
- Troubles santé physique (maladie, handicap)
- Crise relationnelle (40% sans emploi)
- Isolement (45% vivent seul)
- Accès aux moyens
- Contagion

Risque

Chez 90% des suicidés (autopsies psychiatriques):

- | | |
|-------------------|-----|
| ■ Dépression | 50% |
| ■ Tr personnalité | 35% |
| ■ Alcoolisme | 30% |
| ■ Schizophrénie | 6% |